

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus



Kersti Lõhmus

kvaliteediosakonna peaspetsialist, Sotsiaalkindlustusamet

Eestis näitab keskmine eluiga tõusvat trendi. Meie vananevas ühiskonnas kasvab koos eluea pikenemisega ka üksi elavate eakate inimeste arv. See seab hoolekandele uued ülesanded.

Kui lähedased ei saa tagada oma eakate sugulaste toimetulekut, tuleb abi saamiseks pöörduda kohalikkude omavalitsusse, kus selgitatakse välja inimese abivajadus ning vajalikud teenused.

Institutsionaalsele ehk väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele saadetakse inimene alles siis, kui teiste teenustega (koduteenus, isiklik abistaja, tugiisik) ei suudeta tema toimetulekut enam tagada.

2017. aastal kogutud andmed näitavad, et Eestis on üle 160 sellise teenuse pakkuja ehk hooldekodu. Hooldekodu peab tagama turvalise keskkonna ja toimetuleku inimesele, kes oma tervisliku seisundi tõttu iseseisvalt kodus hakkama ei saa.

Üldhooldusteenuse põhimõtted

Nagu kõik Eesti sotsiaalteenused, on ka üldhooldusteenus mõeldud inimese elukvaliteedi parandamiseks või säilitamiseks. Järgida tuleb Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhises kirjeldatud põhimõtteid:

- Teenus on isikukeskne – teenusevajadus on hinnatud, teenus on kättesaadav ja taskukohane;
- Teenus on võimestava iseloomuga –

inimene teab oma võimalusi, kohustusi ja vastutust, tema arengut hinnatakse regulaarselt;

- Teenus on orienteeritud tulemustele – eesmärgid on kokku lepitud, saavutavad ja mõõdetavad;
- Teenus on vajaduspõhine – teenuse planeerimisel hinnatakse ja arvestatakse inimese muutuvaid vajadusi;
- Tagatud on terviklik lähenemine – lähutakse inimesest kui tervikust, tehakse koostööd teiste valdkondade ja teenuse osutajatega.

Inimene võib hooldust vajada ka ajutiselt, näiteks ainult sügisel ja talvel või oma lähedaste puhkuse ajal. Pikema aja jooksul osutatav ajutine hooldus ehk **intervallteenus** või päevane üldhooldusteenus ehk **päevahoid** on meil üsna uued võimalused, kuid need aitavad hooldusvajadusega inimesi kohelda väärilt.

Hooldusteenus koosneb mitmetest tegevustest, igale inimesele tuleb pakkuda just talle vajalikku. Individuaalse ja tervikliku abi tagamiseks viib kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindamisinstrumendi abil läbi abivajaduse hindamise ja teenuseosutaja koostab selle alusel hooldusplaani.

Miks on vaja hooldusplaani?

Hooldusplaani tuleb kliendile koostada 30 päeva jooksul. Ajaline piirang on oluline,

sest nii kohandatakse teenus võimalikult kiiresti inimese vajadustele ning välditakse ebavajalikku hooldust ja selle mõju inimese tervisele. Hooldusplaanide analüüs aitab hooldekodul komplekteerida toetava ja hooliva meeskonna ning planeerida vajalikke tegevusi. Kuna inimese abivajadus muutub, siis tuleb vähemalt poole aasta tagant hooldusplaan üle vaadata.

Ühist hooldusplaani vormi Eestis kehtestatud ei ole, iga hooldekodu saab koostada endale sobiva dokumendi. Nõuetekohane hooldusplaan sisaldab teenuse osutamise eesmärki, tegevusi selle saavutamiseks ja hinnangut ellu viidud tegevustele. Hinnangust peab selguma, kuivõrd on teenus toetanud eaka toimetulekut ja tervislikku seisundit, kuidas see on aidanud elukvaliteeti parandada või säilitada. Äärmiselt oluline on kaasata hooldusplaani koostamisse perearst, pereõde vm tervishoiutöötaja, kes oskab hinnata tervishoiuteenuste vajadust. Üldjuhul toimub esmane tervishoiuteenuste vajaduste hindamine haigla aktiivravi või statsionaarse õendusabi osakonnas või teeb seda inimese perearst.

Õöpäevaringsel üldhooldusteenusel tagatakse lisaks hooldusele ka majutus, toitlustamine jm toimetulekut toetavad tegevused, nt abi liikumisel, ravimite manustamisel, telefoni kasutamisel jne. Hooldusteenust osutavate töötajate arv ja kvalifikatsioon sõltub hooldatavate kõrvalabi vajadusest. Mida suurem see on, seda suurem on ka hoolduspersonali koormus. Miinimumnõudeid personali arvule, mis tagaks klientidele ööpäevaringsed hooldustoimingud, kehtestatud ei ole.

Mitu olulist muutust

Alates 01.01.2020 osutavad hooldusteenust üldhooldekodudes hooldustöötaja ja abihooldustöötaja. Hooldustöötajal peab

olema sobiv ettevalmistus: ta on lõpetanud kas hooldustöötaja kutseõppe tasemeõppe õppekava, hooldustöötaja täienduskoolituse või omandatud hooldustöötaja kutse. Teenust ei saa osutada inimene, keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest.

Sotsiaalhoolekande seaduse järgi (§ 16 lg 3) ei tohi sotsiaalteenuse eest võetav tasu olla teenuse saamise takistuseks. Eri andmetel oli 2017. aastal üldhooldusteenuse hind üle Eesti 500 kuni 1000 eurot kuus. Arvestades vanaduspensionide suurust, võib teenuse eest tasumine jääda eaka lähedaste või kohaliku omavalitsuse kanda. Riigikontroll leiab oma 2014. aastal läbi viidud auditis, et avaliku ehk maksumaksja raha kulutamine peab olema omavalitsustel hästi kaalutletud ja põhjendatud. Omavalitsus peab olema veendunud, et isik ja tema perekond ei ole võimelised üldhooldusteenuse eest ise tasuma. Selleks hindab kohalik omavalitsus eaka ja tema perekonna majanduslikku olukorda, jälgides, et otsus ei kahjustaks pere alaealiste laste heaolu ja toimetulekut.

Samuti leidis Riigikontroll, et ei ole õige nõuda hooldekodu kohamaksumuse katteks eaka kogu pensionit, hooldatavale peaks jääma raha, et katta kulusid, mida hooldekoduteenus ei hõlma. Suur osa Eesti üldhooldusteenuse osutajaid jätab praegu 5–10% eaka pensionist tema isiklike kulude katteks.

Sellest aastast teostab järelevalvet üldhooldusteenuse üle Sotsiaalkindlustusamet. Järelevalve eesmärk on kvaliteetse ja nõuetekohase teenuse pakkumine. 2018. aasta I kvartalis teostati järelevalvet üldhooldusteenuse osutamise üle üheksa teenuseosutaja juures. Viiel korral kaasati Ravimiamet ja Terviseamet.

Ilmnunud probleemid olid seotud hooldusplaanide koostamise, personali nappuse